

18 - 10- SIDA ET GROSSESSE - Pr. BASSIR

La quatrième infection et grossesse, c'est le sida et grossesse. Le VIH est un rétrovirus, son tropisme est immunitaire. Les conséquences physiopathologiques sur la réponse immunitaire sont très importantes.

La transmission mère-enfant est une des causes majeures de l'infection par le VIH, particulièrement dans les pays à faibles ressources et sans accès aux traitements antirétroviraux. Le taux de transmission maternelle fœtale. Sans intervention, ce taux est de 40 à 50 % en Afrique subsaharienne, de 15 à 20 % en Europe et en France.

Il est passé de 20 à 40 % en 1985 sans traitement, à 1 % avec traitement en 2001. Actuellement, le taux de transmission est de 1,5 % dans les pays du Nord, 0,5 % si la charge virale maternelle est contrôlée, et 0,1 % si conception sous traitement. Les différents stades de la transmission du VIH de la mère au fœtus.

La transmission se fait essentiellement au moment de l'accouchement, à peu près 15 %, mais la transmission peut aussi se faire avant l'accouchement unitaire, dans 5 % chez les femmes très immunodéprimées, à partir du deuxième trimestre et après l'accouchement, le rôle important de l'allaitement maternel. La transmission peut se faire unitaire au cours de l'accouchement et au moment de l'allaitement. La transmission est la plus importante au cours de l'accouchement et au cours de l'allaitement, c'est à peu près 15 %, alors que au cours de la grossesse, elle est de 5 %. Les facteurs favorisant la transmission maternelle fœtale du VIH.

Les facteurs liés à l'état d'avancement de la maladie de VIH. S'il y a des signes cliniques du sida, le statut nutritionnel, les CD4, une charge virale élevée, et les infections maternelles associées, à savoir des infections générales, bactériennes virales, des infections locales, des infections génitales et des DIST, ou bien s'il y a une co-infection VIH avec l'hépatite virale C. Il est très important le dosage de la charge virale. Il y a un intérêt pronostic.

Si cette charge virale est inférieure à 50 copies par mille litres, le risque de transmission est de 0,3 %. Alors, si on a une charge virale qui est élevée, supérieure à 10 000, le risque de transmission est le plus important, il est à peu près de 7,3 %. Il n'y a pas de risque nul. Il faut savoir qu'il y a des complications qui peuvent survenir. Elles sont plus importantes au cours de l'accouchement chez une femme qui est infectée, à savoir des infections des annexes, un décollement placentaire, une rupture prématurée des membranes, ou bien un accouchement prématuré.

6,8 % de transmission pour les enfants qui sont nés avant 33 semaines d'améliorer. Et il y a un intérêt pronostic, bien sûr, de l'allaitement maternel, puisque le risque de transmission est à peu près de 15 %. Donc, les facteurs obstétricaux, peut-être soit transplacentaire, par des microtransfusions à travers le placenta, lors d'une choréamniosite ou d'une autre maladie

concomitante avec le VIH. La transmission est également plus importante par voie ascendante si on pratique une amnioscopie ou bien une lésion du scalpe lors d'une toxographie, présence de vaginite ou bien d'herpès génital lors de la rupture prématurée des membranes et au moment de l'accouchement.

On parle d'un effet protecteur important de la césarienne, mais cette césarienne doit être pratiquée avant le travail, avec bien sûr des membranes intactes avant la rupture des membranes. Comment prévenir la transmission materno-foetale du VIH? Par un dépistage, qui doit être systématiquement proposé à toutes les femmes enceintes, bien sûr après consentement des femmes. Un second dépistage peut être proposé au sixième mois de grossesse en cas d'exposition au risque, par exemple une patiente qui a un partenaire qui est infecté ou bien si on a un statut non connu.

Il faut proposer le dépistage du conjoint. La prévention de la transmission en mère-enfant doit concerner les trois périodes à risque de transmission. En père-partum, par un traitement antirétroviral, au moment de l'accouchement, par des protocoles thérapeutiques avec une prise en charge obstétrique appropriée, et en postpartum, par un allaitement artificiel et un traitement systématique du nouveau.

D'où l'importance des suivis pluridisciplinaires si possible sur un site unique, avec des obstétriciens, des cliniciens qui sont spécialisés en VIH, des pédiatres, des virologues et des pharmacologues, des pharmaciens et des psychologues et une assistance sociale. L'enjeu, c'est l'observance du traitement antirétroviral et le suivi de la grossesse. Les modalités de traitement antirétroviral L'objectif, c'est d'obtenir une charge virale indétectable le plus rapidement possible parce que, comme on a vu, si on a une charge virale faible, le risque de transmission au fœtus est faible également.

De diminuer le risque de transmission, d'assurer un traitement optimal pour la mère pour préserver l'avenir thérapeutique et de limiter la toxicité pour l'enfant. Il y a plusieurs schémas thérapeutiques suivant l'accessibilité au traitement. Et la surveillance se fait par l'observance, la tolérance de ce traitement, une surveillance biologique par dosage de CD4, de charge virale, un bilan hépatique, un bilan pour dépistage en diabète, des signes de toxicité métabolique.

Plusieurs traitements sont disponibles et qui sont utilisés. Les risques connus des antirétroviraux Pour le fœtus, il y a risque de malformation, risque de toxicité hématologique, risque de cytopathie métabolique. Pour la grossesse, risque d'accouchement prématuré et de diabète.

Et pour la mère, risque d'acidose lactique et des accidents immunoallergiques. Le dépistage. Il faut dépister systématiquement la VIH au cours de la grossesse.

Il faut proposer un dépistage au futur père ou partenaire des femmes enceintes. Proposer le dépistage au sixième mois de grossesse aux femmes négatives qui étaient négatives au début de la grossesse mais ces femmes sont à grand risque s'ils ont des partenaires multiples ou bien

un partenaire VIH positif. Et proposer un test rapide chez toute femme enceinte dont le statut VIH est inconnu à l'arrivée en salle de travail.

Si la grossesse est débutée sans traitement, quel traitement antirétroviral? En général, ce traitement est sans, prescrit par les infectiologues et propose une trithérapie. Quand débiter le traitement? Le traitement pour la femme si besoin, dès le premier trimestre ou plus tard à la fin du deuxième trimestre. Il faut débiter le plus tôt possible si la charge virale est élevée parce qu'il y a un risque d'accouchement accru d'accouchement prématuré ou bien si on préconise ou prévoit une amniosynthèse.

La surveillance du traitement? Il faut un suivi obstétrique régulier, surveiller la tolérance clinique et une surveillance biologique par un effet plaquette de transaminase et une épidémie qui a débuté sa grossesse sous traitement. Le premier choix c'est une trithérapie. Il y a d'autres alternatives.

Il faut poursuivre ce traitement s'il est efficace et bien toléré chez la femme qui est traitée avant sa grossesse sauf s'il comporte un médicament qui est contre-indiqué, qui est teratogène. En cas de traitement n'ayant pas de données sur la grossesse, il faut discuter le changement de ce traitement ou bien le maintien avec pharmacovigilance. Les femmes non-traitées ou bien le délice tardif? Il y a l'indication thérapeutique sur un test rapide avec information, une trithérapie préconisée, un césarien programmé et de règle superfusion d'azithromycine.

Il faut renforcer la prophylaxie neonatale par une trithérapie, la prise en charge obstétrique il faut prévenir l'accouchement prématuré par le repos, les tocolithiques, l'épistage de traitement systématique des infections cervico-vaginales et des IST. Il faut éviter les manœuvres obstétriques, amnioscopie, décollement des membranes, gel de prostaglandine, BH de scalp, les électrodes de scalp, l'oxymétrie, la topographie interne et discuter la nécessité d'une amniosynthèse si nécessaire ou pas. Le mode d'accouchement, la place de la césarienne programmée, il n'y a pas de place si la charge virale est contrôlée, effet protecteur est prouvé lorsque la charge virale est élevée, pas d'effet protecteur du césarien au cours du travail, c'est une décision à prendre au cas par cas avec la femme enceinte à la fin du huitième mois.

Il n'y a pas de bénéfice de la césarienne programmée en cas de charge virale basse. Le traitement du nouveau-né par l'azithromycine pendant quatre semaines, intensification de la prophylaxie post-exposition si la mère est non traitée ou bien une charge virale élevée, il faut un suivi de deux ans pour voir la toxicité du traitement. Le diagnostic de nos infections, on réalise un PCR à J3, M1, premier mois, troisième mois et sixième mois.

La valeur prédictive négative est de 99% à un mois si l'enfant n'est pas traité, à trois mois s'il est traité. Un contrôle à six mois et des sérologies à 18 mois, sans préconiser. Quel obstacle courant? C'est le secret médical qu'il faut respecter.

Ce sont des femmes qui lignent leurs procès, donc il faut un suivi psychologique avec ces femmes enceintes qui généralement refusent le soin, donc il faut une prise en charge psychologique associée. Et, bien sûr, en cas d'urgence, il faut une prise en charge. La prise en charge ne doit pas être tardive.

Également, en cas d'urgence, les obstacles qui peuvent être présents, ce sont les complications obstétricales qu'il faut gérer et la toxicité médicamenteuse. En conclusion, le dépistage par l'information à la prévention et le secret qui doit être partagé entre médecins et malades, c'est une grossesse à risque qui nécessite un suivi prioritaire. Il faut un suivi disciplinaire, il faut informer des bénéfices et du risque du traitement, il faut avoir un suivi renforcé, de préférence dans un site unique avec un soutien de l'observance et il faut une surveillance de la maman et de son enfant après l'accouchement.

Je vous remercie.